심방조기수축(PAC) 심방세동과 다른가요?

조기수축의 의미와 심전도를 더 기록하는 이유

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

PAC와 심방세동은 같은 진단이 아닙니다

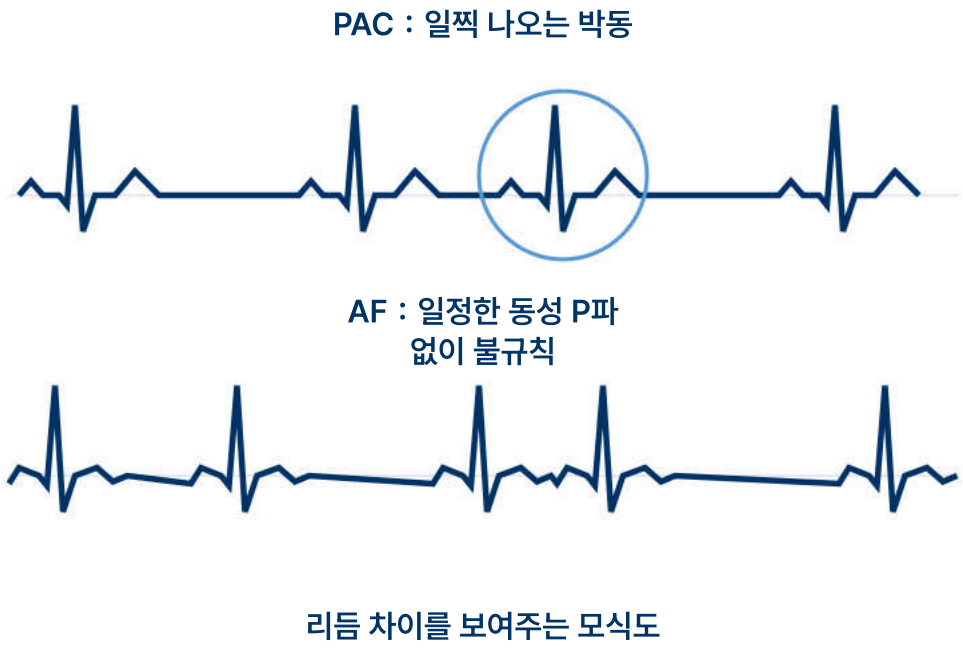
심전도에서 심방의 신호와 리듬을 구별합니다

PAC · 심방조기수축

심방에서 정상 순서보다 일찍 나오는 박동입니다. 강의에서는 흔히 양성으로 여겨온 부정맥으로 소개하며, 자주 보일 때는 이후 경과를 살펴야 한다고 설명했습니다.

AF · 심방세동

일정한 정상 동성 P파가 보이지 않고 심실 반응이 불규칙한 리듬입니다. PAC가 매우 잦으면 혼동할 수 있어, 연자 Q&A는 긴 리듬 기록이 도움이 된다고 설명합니다.



리듬 차이를 보여주는 모식도

심전도에서 심방의 신호와 리듬을 구별합니다 · 설명용 도식

> 심전도에서 심방의 신호와 리듬을 구별합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

한 장의 심전도와 하루 동안의 기록은 다릅니다

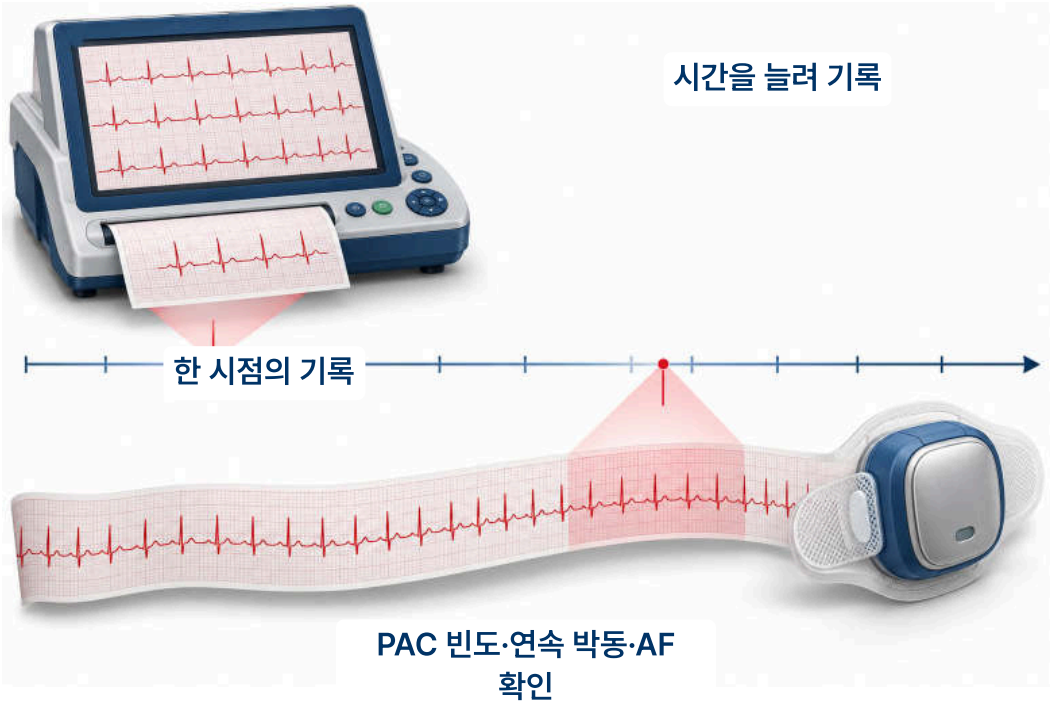
얼마나 자주 생기고, 어떤 리듬이 동반되는지 봅니다

심전도 · ECG

진료실의 12유도 심전도는 그때의 리듬을 봅니다. 두근거림과 부정맥이 관련되는지 살피는 출발점입니다.

홀터·패치 기록

시간을 늘려 PAC의 빈도(burden), 연속 박동, 숨어 있는 심방세동이 있는지 확인합니다. 증상이 있을 때의 기록과 맞춰 보는 것이 도움이 됩니다. 고령·고혈압·좌심방 확대가 있으면 더 자세한 기록을 고려합니다.



얼마나 자주 생기고, 어떤 리듬이 동반되는지 봅니다 · 설명용 도식

얼마나 자주 생기고, 어떤 리듬이 동반되는지 봅니다

PAC가 잦으면 추적을 더 살피는 이유가 있습니다

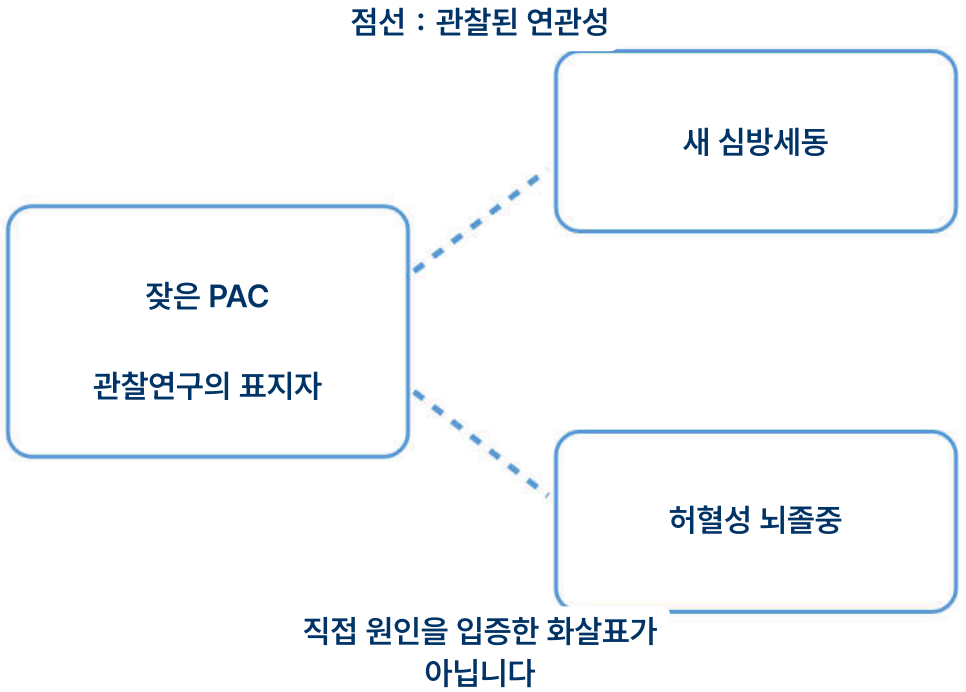
연관성이 있다는 결과가 직접 원인이라는 뜻은 아닙니다

강의에 소개된 관찰연구

중년·고령 인구에서 잦은 심방의 조기박동 및 짧은 연속 박동이 허혈성 뇌졸중과 관련됐습니다. 다른 연구에서는 사망·심혈관 입원·새 심방세동·심박동기 삽입과도 연관됐습니다.

개인의 운명을 정하는 숫자는 아닙니다

강의는 심방세동 발생과 뇌졸중 위험이 약 2배와 연관된 자료를 소개했습니다. PAC가 반드시 AF를 거쳐 뇌졸중을 일으킨다는 인과 경로를 입증한 결과로 읽지는 않습니다.



연관성이 있다는 결과가 직접 원인이라는 뜻은 아닙니다 · 설명용 도식

연관성이 있다는 결과가 직접 원인이라는 뜻은 아닙니다

심방의 상태가 여러 모습으로 드러날 수 있습니다

강의는 심방근병증이라는 개념으로 설명합니다

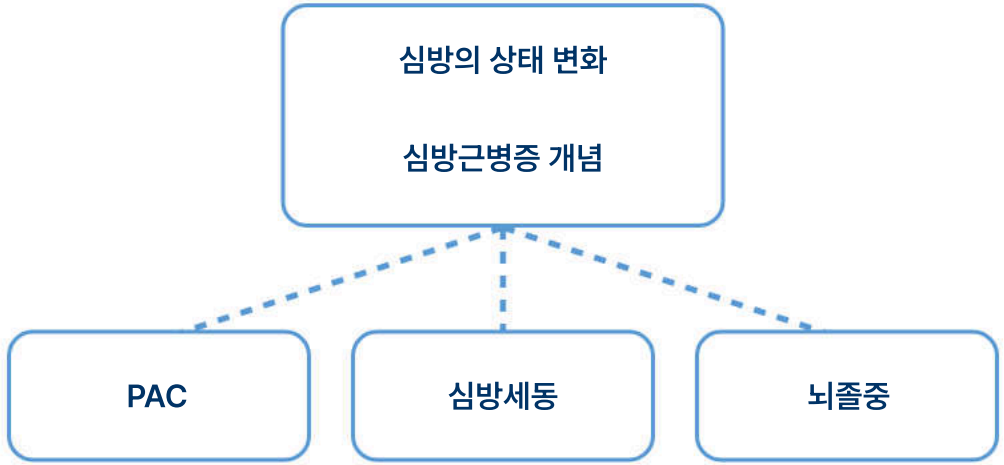
공통 배경을 살핍니다

심장질환이나 전신질환이 있을 때 심방의 상태가 변하고, PAC·심방세동·뇌졸중이 그와 관련된 여러 모습으로 나타날 수 있다는 개념입니다.

그래서 감시가 중요합니다

연자는 PAC → AF → 뇌졸중이라는 한 줄의 순서만으로 보지 않는다고 설명했습니다. 고령이거나 혈전 위험인자가 많으면 홀터 등으로 실제 심방세동이 생기는지 더 주의 깊게 관찰합니다.

공통 배경의 여러 발현



강의는 심방근병증이라는 개념으로 설명합니다 · 설명용 도식

> 강의는 심방근병증이라는 개념으로 설명합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

연구 기준과 상담 기준을 구별합니다

숫자가 높다는 이유만으로 치료가 자동 결정되지는 않습니다

구분	설명
강의의 관찰연구 정의	시간당 >30 PAC 또는 >20개 PAC 연속 박동으로 과도한 심방 조기활동을 정의한 연구 소개
강의 요약 슬라이드	ESVEA: 시간당 ≥30 PAC 또는 ≥20회 심방 연속 박동으로 표기
연자 Q&A · 고빈도	>500 PAC/24시간을 고빈도로 보아 장기 리듬기록을 고려하는 합의문 제안 소개
수치의 쓰임	서로 다른 자료의 정의입니다. PAC를 몇 % 이상이면 반드시 치료한다는 확립된 기준은 없다고 설명

숫자가 높다는 이유만으로 치료가 자동 결정되지는 않습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

PAC만으로 항응고제를 시작하지 않습니다

심방세동을 확인했을 때의 치료 판단과 구별합니다

PAC가 많을 때

연자 Q&A: PAC가 많다는 이유만으로 항응고를 시작하지 않으며, 무증상 PAC를 항부정맥제로 적극 억제해야 한다는 근거도 없다고 설명합니다.

심방세동이 확인됐을 때

별도로 뇌졸중 위험을 평가해 항응고 치료 여부를 결정합니다. PAC 추적의 중요한 목표는 실제 심방세동을 조기에 발견하는 것입니다. PAC와 AF의 처방을 같은 것으로 생각하지 않습니다.

심방세동을 확인했을 때의 치료 판단과 구별합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

불편한 증상과 위험인자를 함께 살핍니다

연자 Q&A가 설명한 PAC 관리 방향입니다

증상이 심한가요

심하면 베타차단제 등 증상 치료를 고려할 수 있습니다.

혈압 관리

고혈압은 심방세동 위험인자 관리의 한 영역입니다.

비만·수면무호흡

체중과 수면무호흡 등 관련 위험인자를 함께 관리합니다.

치료 목적

PAC를 줄이는 항부정맥제가 뇌졸중이나 심방세동을 예방한다는 근거는 없다고 설명합니다.

연자 Q&A가 설명한 PAC 관리 방향입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이런 증상은 기록과 전문 진료를 더 살핍니다

연자 Q&A에서 제시한 두근거림 환자의 의뢰 상황입니다

실신·전실신

정신을 잃거나 잃을 듯한 증상이 두근거림과 동반되는 경우

심한 흉통·숨참

두근거릴 때 심한 흉통이나 호흡곤란이 동반되는 경우

심장질환 동반

구조적 심질환·심부전·심근경색이 의심되거나 확인된 경우

심한데 진단이 안 될 때

심한 증상이 있어도 리듬이 확인되지 않아 장기 모니터링이나 추가 평가가 필요한 경우

연자 Q&A에서 제시한 두근거림 환자의 의뢰 상황입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진료에서 확인할 네 가지를 기억하세요

검사명보다 검사로 알고 싶은 내용을 먼저 확인합니다

01 진단

PAC인지 AF인지, 심전도 설명을 듣습니다.

02 기록

PAC 빈도와 연속 박동, 더 오래 기록할 필요를 확인합니다.

03 관리

증상 치료와 혈압·비만·수면무호흡 관리를 구분해 상의합니다.

04 추적

새 심방세동을 찾는 기록과 진료 계획을 확인합니다.

검사명보다 검사로 알고 싶은 내용을 먼저 확인합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 다음 진료를 함께 정합니다

조기수축의 의미와 심전도를 더 기록하는 이유

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료